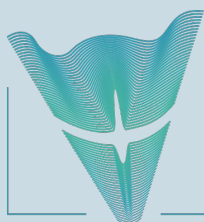


Guia para mulheres sobre a endometriose

E-BOOK GRATUITO



INSTITUTO DE
**ENDOMETRIOSE
DE BRASÍLIA**



ÍNDICE

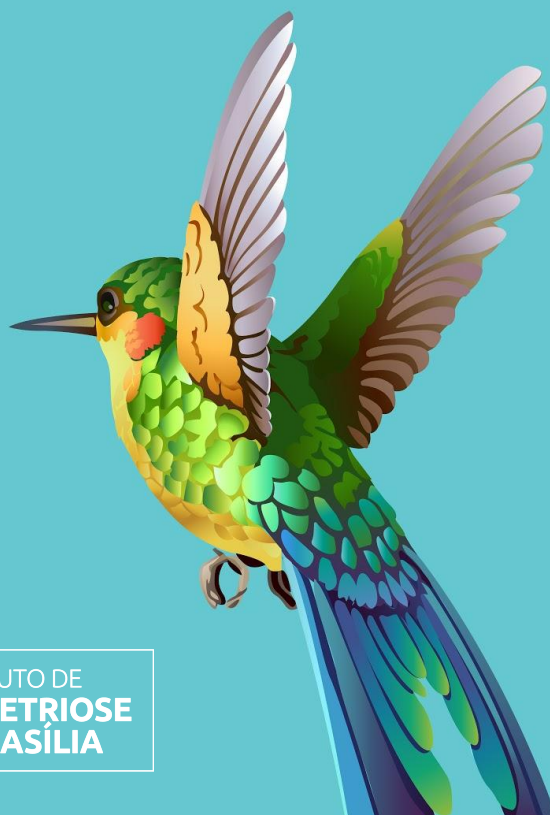
03	Prefácio
08	Introdução
09	O que é a endometriose?
10	Como surge a endometriose?
11	Quais os principais sintomas da endometriose?
13	O que esses sintomas provocam na vida da mulher?
14	Como fazer o diagnóstico?
15	Quais os tratamentos?
16	Quais as indicações de cirurgia?
18	Qual o objetivo da cirurgia?
21	Como é o tratamento clínico da endometriose?
27	Perguntas frequentes

Os *links* do índice são clicáveis para facilitar a navegação

Prefácio

“O próprio viver é morrer, porque não temos um dia a mais na nossa vida que não tenhamos, nisso, um dia a menos nela.”

Essa citação é do Fernando Pessoa, poeta importante da língua portuguesa, nascido em Portugal em 1888, cuja obra assombrou minhas provas de vestibular nas vésperas dos anos 2000.



INSTITUTO DE
**ENDOMETRIOSE
DE BRÁSILIA**

Prefácio

Mas, voltando à frase, **o morrer tinha que ter começado tão cedo pra mim?**

Lembro como se fosse hoje o dia em que eu comecei a morrer: doze de julho de mil novecentos e noventa e oito.

Eu tinha 12 anos, 5 meses e 7 dias.

Alguns podem pensar que a causa de tanto sofrer foi um amor platônico que eu vi partir, como o professor de literatura, que recita poemas durante as aulas, e que não iria voltar depois das férias para fazer um mochilão pela Europa; ou o amigo gato da minha irmã mais velha que quebrou meu coração ao sair com a patricinha popular da escola; ou até mesmo a *boyband* do momento que se desfez. Provavelmente, o aficionado por futebol vai dizer: “foi a final da Copa do Mundo de futebol na França, o pai do meu vizinho morreu de desgosto vendo aquele jogo”.

Não foi nada disso.

**Nesse dia eu
fiquei menstruada
pela primeira vez.**



Prefácio

Nesse dia, minha mãe me apresentou ao Pronto Socorro do hospital, local que virou minha segunda casa durante muitos anos.

A partir desse dia eu também aprendi o quanto as pessoas podem ser rudes e indiferentes com aquilo que desconhecem.

Cheguei em um Pronto Socorro vazio e escutei uma voz perto da triagem:

__ Não é nada, é só uma colicazinha.

Fiquei esperando sentada em um banco frio enquanto ninguém era atendido até quando chegou um rapaz com pedra nos rins que passou na minha frente.

E por fim, só fui atendida quando fizeram o terceiro gol.

Ao longo dos anos eu escutei muito:

__ Lá vem ela com mais um atestado.
Aposto que faz isso para chamar atenção.
Isso é frescura, mimimi.

Naquele dia, EU ESTAVA DE FÉRIAS! E eu era só uma menina!





Prefácio

E foi só piorando ao longo dos anos.
Cansei de escutar conselhos:

- ___ Antes de casar sara.
- ___ Depois que engravidar melhora.
- ___ Lá vem ela de novo, atestado esse mês também.

Desculpe, não me apresentei. Meu nome é Maria. Mas, também posso ser a Flávia, Janaína, Patrícia...

Somos 10% das mulheres do mundo. Sentimos cólicas menstruais incapacitantes, dor na relação sexual, infertilidade e, mesmo contra nossa vontade, às vezes não dá nem para sair da cama. E, por isso, inevitavelmente podemos não conseguir trabalhar, transar ou até engravidar. Mas, o que mais nos machuca é a indiferença e o julgamento que recebemos.

E essa é a ENDOMETRIOSE.

01 INTRODUÇÃO

Tratar a Endometriose não é simples, mas você vai conseguir.

Não existe fórmula mágica e cada tratamento deve ser individualizado.

O tratamento cirúrgico não é milagroso e na maioria das vezes necessita do tratamento clínico associado.

A cirurgia deve ser feita por uma equipe multidisciplinar com treinamento em Endometriose para realizar obter a ressecção completa de todos os focos de lesão.

Ela promove uma melhora clínica importante e aumenta as chances de gravidez. Porém, pode haver recidiva da doença mesmo com a cirurgia adequada.

O tratamento clínico é difícil de ser realizado porque envolve mudanças em hábitos de vida.

A Endometriose não é frescura e vocês não estão sozinhas.

Estamos com vocês!



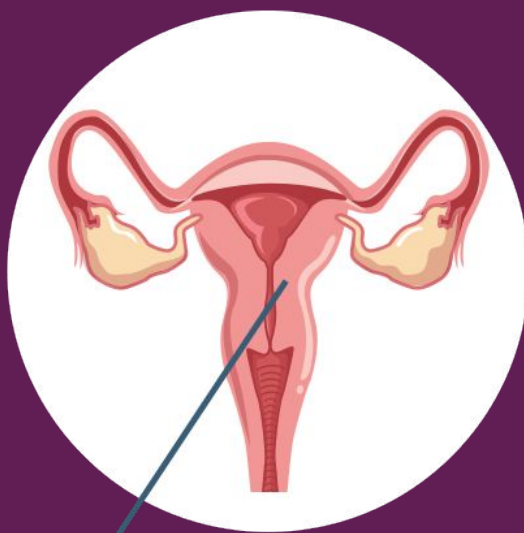
INSTITUTO DE
**ENDOMETRIOSE
DE BRASÍLIA**

02 O que é a endometriose?

Endometriose é uma doença inflamatória e crônica, que se caracteriza pela presença de tecido de origem do Endométrio (camada que reveste a parte interna do útero) fora da cavidade uterina.

Ela está associada à dismenorreia (cólica menstrual), dispareunia (dor na relação sexual), infertilidade e outros sintomas.

Em geral, as cólicas menstruais se iniciam no fim da adolescência ou início da vida adulta e têm piora progressiva ao longo dos anos.



Apesar de apresentar sintomas bem característicos, o diagnóstico de Endometriose demora em média 7 a 10 anos após o início dos sintomas para ser feito.

03 Como surge a Endometriose?

Existem algumas teorias porém nenhuma delas é 100% conclusiva.

Em todo ciclo menstrual, os ovários produzem hormônios que estimulam o crescimento do Endométrio para preparar o útero para uma gravidez. Não ocorrendo a gravidez, vem a menstruação e parte do tecido endometrial sai com o sangramento.

O tecido de Endometriose recebe esse mesmo estímulo hormonal fora do útero. Porém, no período menstrual, esse tecido gera um processo inflamatório intenso ao seu redor, o que causa as dores da menstruação.

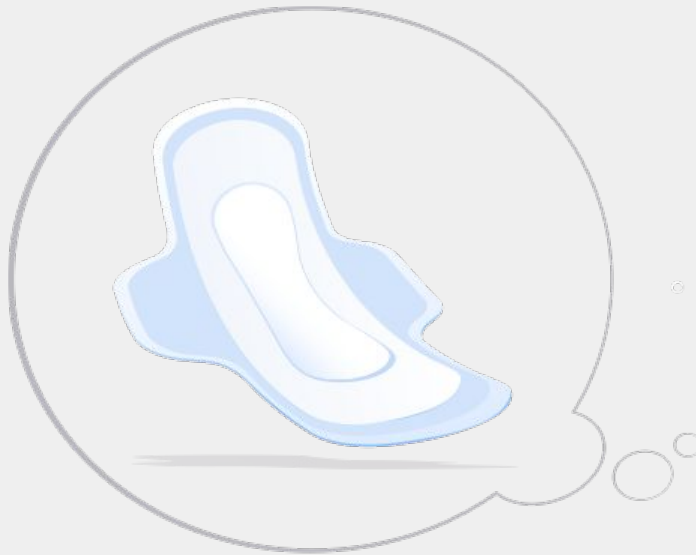
Esse processo inflamatório pode crescer tanto ao longo dos anos que a dor passa a ser contínua.

Além disso, a inflamação pode atingir outros órgãos e não ser mais apenas a cólica menstrual.

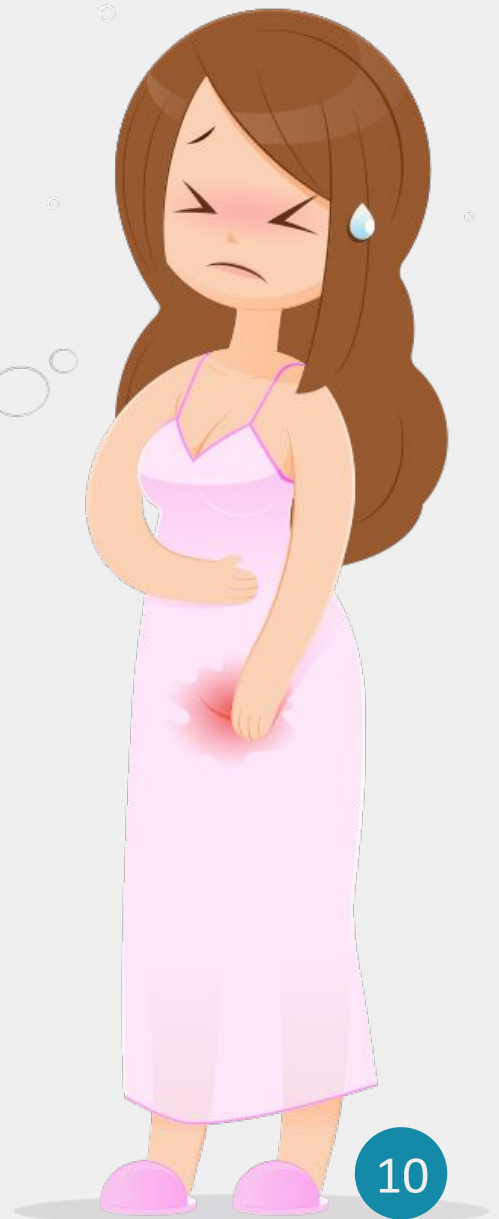


04 Quais os principais sintomas da Endometriose?

1. Dismenorreia (cólica menstrual)
2. Dispareunia (dor na relação sexual)
3. Dificuldade para engravidar



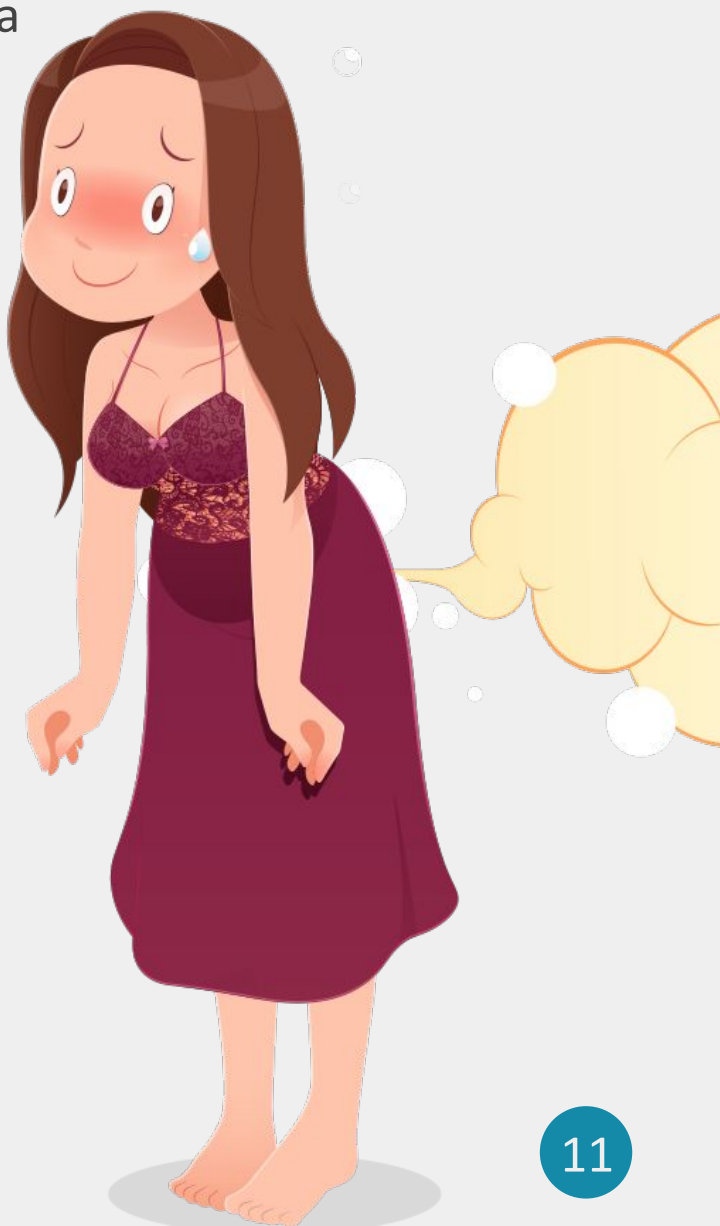
Mas não são os únicos. Os sintomas geralmente começam restritos ao período menstrual e na adolescência ou início da vida adulta, mas depois podem ficar constantes.



04 Quais os principais sintomas da Endometriose?

As pacientes também podem apresentar:

- Disquezia (dor ao evacuar)
- Constipação ou diarreia
- Distensão abdominal
- Dor pélvica crônica contínua
- Dor lombar
- Dor perineal
- Dor irradiada para as pernas



05 O que esses sintomas provocam na vida da mulher?



- Cólica menstrual incapacitante que causa: faltas na escola, faculdade e trabalho.
- Ir a estes locais para não tomar falta ou tirar atestado e não conseguir produzir.
- Visitas frequentes ao Pronto Socorro.
- Dor na relação sexual que causa: “fugir do parceiro” para não ter que dizer não. Fingir que não dói para agradar o parceiro (POR FAVOR, NÃO FAÇAM ISSO!).
- Infertilidade: ver suas amigas e parentes engravidarem e terem filhos e você não conseguir. Fazer fertilização *in vitro* e gastar muito dinheiro para tentar engravidar.

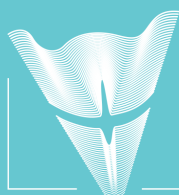
ESCUTAR QUE É FRESCURA:
#EndometrioseNãoÉFrescura!

06 Como fazer o diagnóstico?

O diagnóstico de Endometriose é clínico.

Fazemos esse diagnóstico de acordo com as queixas clínicas da paciente e o exame físico. Mas então porque fazemos os exames de imagem?

Os exames servem para identificar os locais de acometimento por Endometriose profunda e ajudar na indicação e planejamento da cirurgia.



INSTITUTO DE
**ENDOMETRIOSE
DE BRASÍLIA**

06 Como fazer o diagnóstico?

Os exames indicados são:

1. Ressonância magnética de abdome e pelve com preparo intestinal, gel retal e vaginal e contraste venoso para investigar Endometriose;
2. Ecografia transvaginal com preparo intestinal para investigar Endometriose.

O ideal é sempre fazer o exame com um especialista para ter o resultado mais fidedigno, avaliar a indicação da cirurgia e fazer o planejamento cirúrgico, quando necessário.



07 Quais as indicações de cirurgia?

Os casos de cirurgia devem ser discutidos e cuidadosamente avaliados com seu médico assistente. Elas costumam ser indicadas nos seguintes casos:

1- Falha no tratamento clínico

Paciente com todo o tratamento clínico multidisciplinar implementado que persiste com dor.

2-Comprometimento de órgãos

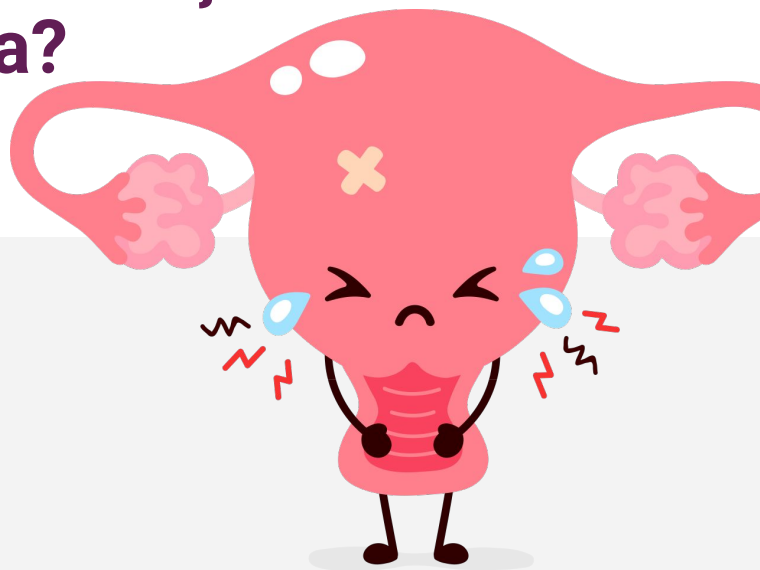
Ocorre em geral por acometimento intestinal, urinário ou dos órgãos reprodutores.



INSTITUTO DE
**ENDOMETRIOSE
DE BRASÍLIA**



07 Quais as indicações de cirurgia?



3-Intestinal:

A presença de uma lesão intestinal não é indicação absoluta de cirurgia, porém, paciente com sintomas intestinais que não melhoram com o tratamento clínico e que tem algum sinal de semi-obstrução intestinal deve ser operada.

4-Urinário:

As indicações principais são sintomas urinários que não melhoram com tratamento clínico, sinais de semi-obstrução do ureter ou comprometimento renal e lesão vesical com comprometimento da mucosa.

5-Órgãos reprodutores:

Obstrução tubária e hidrossalpinge, endometriomas ovarianos de grande elevado, casos de infertilidade.

08 Qual o objetivo da cirurgia?

Retirar todos os focos de Endometriose identificáveis na paciente.

A cirurgia ideal retira todas as lesões e deve ser feita por videolaparoscopia ou robótica. SEMPRE!

Os focos podem ser de difícil localização e estar em locais muito delicados como nervos pélvicos, ao redor de vasos sanguíneos, ureteres ou promovendo aderências e comprometimento intestinal.

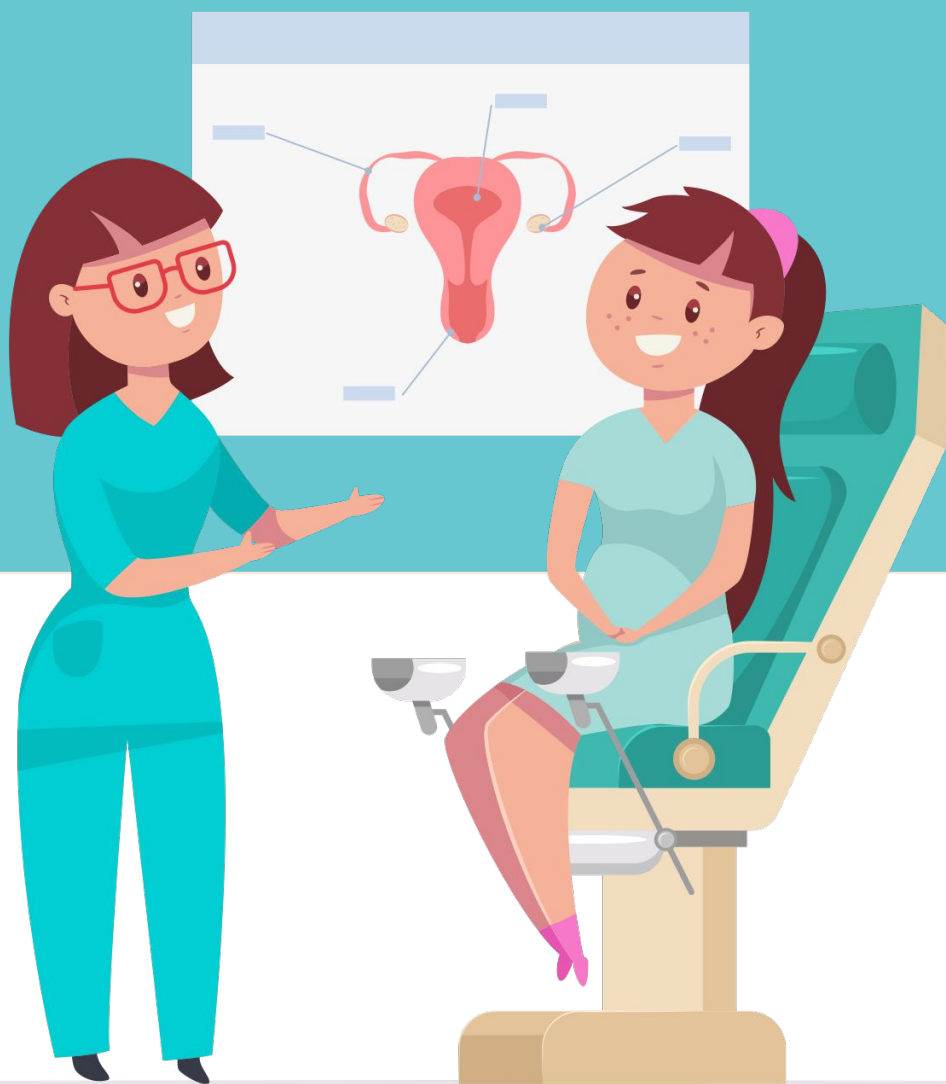
Por isso, é fundamental a realização da cirurgia por uma equipe multidisciplinar treinada em Endometriose.

A cirurgia retira todos os focos da doença e com isso minimiza a inflamação da pelve; porém, a dieta anti-inflamatória e a fisioterapia devem continuar para obtenção de um melhor resultado.

É indicado o uso de medicação hormonal por pelo menos 6 meses no pós-operatório para diminuir as chances de recidiva.



09 Como é o tratamento clínico da Endometriose?



O tratamento é baseado em 5 pilares:

1. **Medicações hormonais:**
Bloqueio do ciclo hormonal e do ciclo da dor;
2. **Medicações para alívio da dor:**
Para quando ela surgir e interromper a piora dos sintomas;
3. **Dieta anti-inflamatória:**
Diminuição dos sintomas intestinais e urinários associados à alimentação;
4. **Fisioterapia, alongamento e atividades físicas:**
Diminuir a inflamação, aliviar pontos de tensão na musculatura e liberar endorfina para modulação da dor;
5. **Cuidados com a mente:**
Psicologia e Meditação;



INSTITUTO DE
**ENDOMETRIOSE
DE BRÁSILIA**

09 Como é o tratamento clínico da Endometriose?

O tratamento clínico da endometriose é realizado por uma equipe multidisciplinar, composta por ginecologista, fisioterapeuta, nutricionista e psicólogo.

Profissional de educação física, instrutor de meditação ou yoga, acupunturista, especialista em dor e enfermeira também exercem papel importante.



09 Como é o tratamento clínico da Endometriose?

Medicações hormonais

Objetivo: Bloqueio do ciclo hormonal e do ciclo da dor.

Indicação: Indicação: Bloquear o ciclo hormonal. Muitas pacientes precisam bloqueá-lo para cortar a dor pois a endometriose recebe estímulo dos hormônios ovarianos.

Formas de uso: Oral combinado (contínuo ou não), progesterona isolada, DIU hormonal, creme ou anel vaginal, implante subcutâneo.

Medicações para alívio da dor

Objetivo: Bloquear a dor no seu início e parar o ciclo da dor.

Primeira linha: Analgésicos, anti-inflamatórios, anti-espasmódicos, medicações para gases (para quem tem sintomas intestinais e distensão abdominal).

Segunda linha: Otimizar o uso dessas medicações, combinando mais de uma e usando doses máximas.

Terceira linha: Medicações de ação central (anticonvulsivantes e anti epilépticos) que atuam no tratamento da dor neuropática.

Quarta linha: Opióides

Quinta linha: Antidepressivos



Os tratamentos podem ser associados e não é obrigatório seguir essa ordem. Cada caso deve ser individualizado.

NUNCA tome nenhuma medicação sem ser prescrita pelo seu médico.

Dieta anti-inflamatória

Objetivo: Diminuição dos sintomas intestinais e urinários associados à alimentação, como dor ao evacuar, distensão abdominal, constipação e dor ao urinar ou ao enchimento da bexiga.

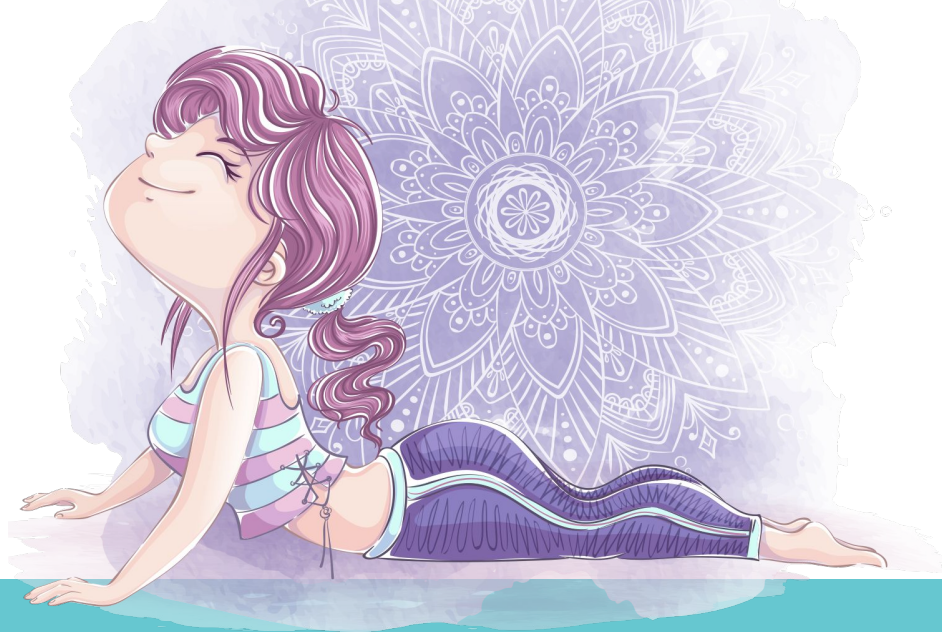
Pacientes com Endometriose apresentam inflamação e dor crônicas na pelve e por consequência, no intestino.

Sabemos que muitos alimentos são pró-inflamatórios ou causam piora dos sintomas intestinais das pacientes e por isso devem ser evitados: refrigerante, café, álcool, glúten, lactose, embutidos, defumados, carne vermelha e gordura animal.

Alguns alimentos são anti-inflamatórios e/ou ajudam a regular o ritmo intestinal e devem ser incluídos na sua dieta: limão, ameixa, mamão, abacate, castanhas, peixe, arroz integral, aveia, verduras e legumes..

**E os campeões:
CÚRCUMA e GENGIBRE.**





Fisioterapia, alongamento e atividades físicas

Objetivo: Diminuir a inflamação, aliviar pontos de tensão na musculatura e liberar endorfina para modulação da dor.

Os três podem ser feitos isoladamente de acordo com a evolução da paciente ou em conjunto.

A Fisioterapia ajuda a diminuir o processo inflamatório na pelve, aliviar a contratura muscular dos músculos da pelve, abdome, lombar e membros inferiores e melhorar a dor na relação sexual.

O alongamento ajuda na postura e relaxamento dos músculos do abdome, lombar, pelve e pernas que são acometidos pela inflamação da Endometriose.

A atividade física, além de promover inúmeros benefícios à saúde, também ajuda a modular a dor promovendo liberação de endorfinas.



Cuidados com a mente (Psicologia e Meditação)

Sentir dor ao menstruar, dor na relação sexual, dor ao evacuar, alteração no ritmo intestinal, infertilidade, cólicas incapacitantes que te impedem de trabalhar e escutar que isso é frescura não é fácil.

Precisamos cuidar da saúde mental dessas pacientes também: psicologia, meditação e yoga são meios para isso.

10

PERGUNTAS FREQUENTES



- Histerectomia cura a Endometriose?

Não!

Histerectomia é apenas a retirada do útero, essa cirurgia cura mioma ou pólipos endometrial.

A cirurgia de Endometriose deve ser feita para retirar todos os focos de lesão da doença e se eles estiverem no útero, a histerectomia é apenas um dos passos da cirurgia.

- Quando atinge os ovários, tem que operar?

Endometriomas ovarianos com mais de 4 cm têm indicação de cirurgia mas quando são menores e assintomáticos, não.

- Drenagem linfática e massagem modeladora podem ser feitas por quem tem Endometriose?

Podem e ajudam no relaxamento muscular da pelve, pernas e abdome.



INSTITUTO DE
**ENDOMETRIOSE
DE BRASÍLIA**

10

PERGUNTAS FREQUENTES

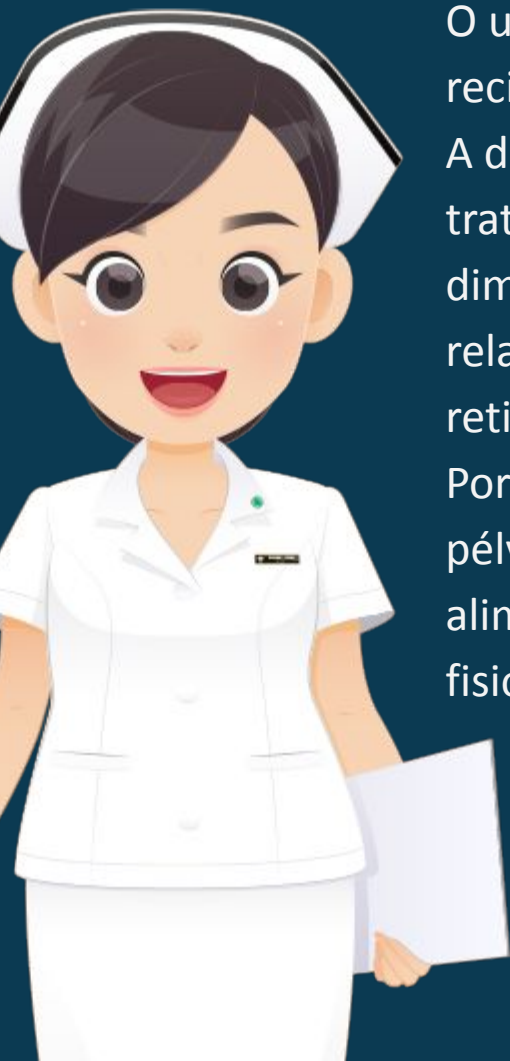
- A Endometriose pode voltar em quem fez a retirada do útero?

Infelizmente sim, as chances são maiores quando haviam endometriomas nos dois ovários antes da cirurgia.

- Qual a importância do tratamento clínico para quem já fez a cirurgia?

O uso de hormônio diminui as chances de recidiva.

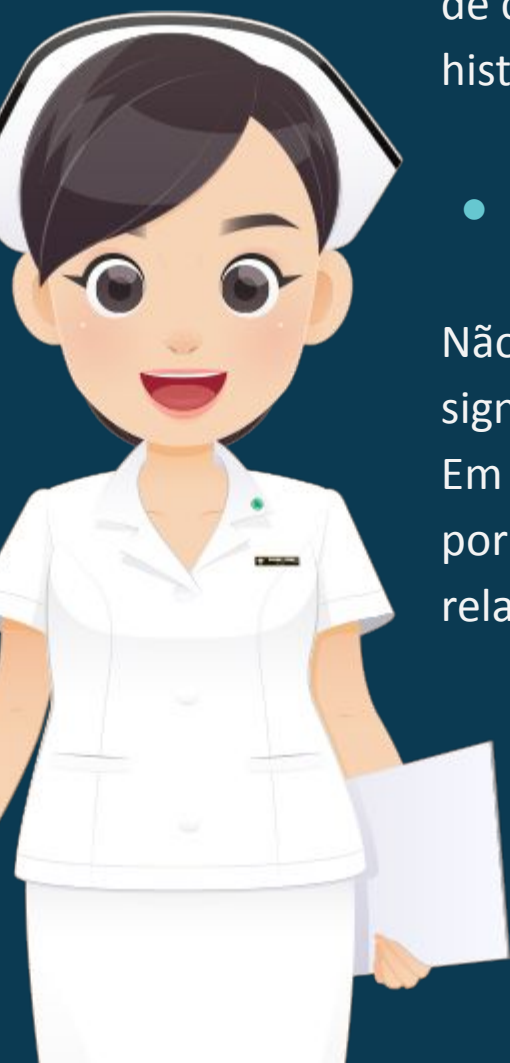
A dieta e fisioterapia são auxiliares no tratamento e melhoram a inflamação na pelve, diminuem sintomas intestinais e promovem relaxamento da musculatura pélvica. A cirurgia retira as lesões e a inflamação ao seu redor. Porém, muitos pontos de dor na musculatura pélvica e a sensibilidade intestinal a alguns alimentos permanecem. Por isso, a dieta e a fisioterapia devem ser realizadas.



INSTITUTO DE
**ENDOMETRIOSE
DE BRASÍLIA**

10

PERGUNTAS FREQUENTES



- A Endometriose pode voltar depois da cirurgia se parar de tomar as medicações?

A Endometriose pode voltar. O uso de hormônio no pós-operatório diminui o risco de recidiva.

As chances de recidiva variam de acordo com os achados anteriores à cirurgia, como a presença de lesões ovarianas bilaterais e o tipo de cirurgia realizada – com ou sem histerectomia.

- Fazer histerectomia diminui a libido?

Não. A histerectomia não altera de maneira significativa a produção hormonal dos ovários. Em alguns casos como cirurgia de histerectomia por prolapso uterino ou por miomas, há relatos de melhora da libido após a cirurgia.



INSTITUTO DE
**ENDOMETRIOSE
DE BRÁSILIA**



- Tenho Endometriose e dor nas pernas. Tem relação entre as duas?

Pode haver sim. A inflamação da Endometriose pode atingir alguns nervos da pelve que vão para as pernas e causar esse tipo de dor.

- Posso menstruar ou ovular mesmo usando anticoncepcional?

Pode. Não é rara a presença de escapes menstruais com o uso de anticoncepcionais contínuos.

Em geral, são sangramentos de pequeno volume, em borra de café, com poucos dias de duração. A maior parte dos anticoncepcionais não impedem a ovulação.

- Quais os tipos de cirurgia para Endometriose?

A cirurgia indicada para Endometriose é por laparoscopia ou robótica, com a ressecção de todos os focos da doença. A realização ou não da histerectomia deve ser discutida individualmente com o seu médico.



Sobre o Ela

Instituto de Endometriose de Brasília



INSTITUTO DE
**ENDOMETRIOSE
DE BRASÍLIA**

Maternidade Brasília -
Consultórios Médicos
Brasília
Endereço QMSW 6 lote
11/12
Salas 8 e 9

Marcação de Consulta:
(61) 3315-1048 | WhatsApp
(61) 99901-2277

O Instituto de Endometriose de Brasília possui uma equipe extremamente capacitada, com profissionais que se dedicam há anos ao estudo do tratamento da Endometriose. Você terá acesso a profissionais que abordam de maneira multidisciplinar todos os aspectos dessa doença complexa, a fim de compreender o seu caso como único, esclarecer o seu diagnóstico, e definir o melhor tratamento para você!

A Medicina define o método clínico centrado no paciente, não apenas na doença. Assim, devemos entender bem cada aspecto da relação entre a paciente e a doença, bem como a modificação causada em sua vida.

Conte conosco para buscar a qualidade de vida que você merece!



INSTITUTO DE **ENDOMETRIOSE DE BRASÍLIA**



@elaendometriose



elaendometriose

www.elaendometriose.com.br

Design editorial: Agência Conectando Pessoas
Criação do projeto gráfico, capa, diagramação e arte final

conectandopessoas
comunicação e marketing